

TEMA 9.24 • RESPIRATORIO

Manejo Crónico del Asma

PERFIL EUNACOM 1.01.1.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO) Secundario** se refiere a la presencia de sibilancias y obstrucción de la vía aérea que no se explica por la hiperreactividad bronquial primaria (como el asma), sino por una patología de base subyacente. Identificar estas causas es fundamental para un manejo específico y evitar el daño pulmonar crónico.

1. Cardiopatías Congénitas

Las cardiopatías congénitas pueden manifestarse con síntomas respiratorios obstructivos debido a la compresión de la vía aérea por estructuras vasculares o por el edema intersticial secundario a la falla cardíaca.

Sospecha Clínica

Se debe sospechar ante un lactante con SBO recurrente que presenta: - **Soplos cardíacos**: - **Holosistólico (o pansistólico)**: Característico de la Comunicación Interventricular (CIV). - **En maquinaria (sistodiastólico continuo)**: Característico del **Ductus Arterioso Persistente (DAP)**. - **Sistólico eyectivo (mesosistólico)**: Característico de la Comunicación Interauricular (CIA). - **Cardiomegalia en radiografía**: - La CIA suele dilatar cavidades derechas. - La CIV y el DAP suelen dilatar cavidades izquierdas.

Diagnóstico y Manejo

- **Diagnóstico**: El examen de elección es la **ecocardiografía**, que permite identificar la anatomía y el flujo hemodinámico. - **Tratamiento**: - **Cirugía**: Cierre del defecto con prótesis (ej. doble paraguas) o cirugías complejas. - **Farmacológico (DAP)**: Se utilizan AINEs como **ibuprofeno** o **indometacina** para inducir el cierre del ductus. - **Trasplante cardíaco**: Reservado para casos terminales o malformaciones no corregibles.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En cardiopatías cianóticas **ducto-dependientes**, el cierre del ductus puede ser fatal. En esos casos se utilizan **prostaglandinas** para mantenerlo abierto hasta la cirugía. Los AINEs solo se usan cuando el objetivo es cerrar un DAP aislado.

2. Fibrosis Quística (FQ)

La **Fibrosis Quística** es una enfermedad genética autosómica recesiva que afecta el transporte de cloro, generando secreciones espesas y deshidratadas.

Sospecha Clínica

- **Respiratorio**: Bronquiectasias (dilatación irreversible de bronquios), SBO recurrente y neumonías a repetición. - **Microbiología**: Infecciones frecuentes por *Staphylococcus aureus* y, especialmente, *Pseudomonas aeruginosa*. - **Digestivo**: **Síndrome de mala absorción** debido a insuficiencia pancreática exocrina, lo que se traduce en diarrea crónica (esteatorrea) y desnutrición.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de la FQ implica un déficit del páncreas exocrino. La falta de enzimas digestivas impide la absorción de grasas y nutrientes, causando la diarrea característica que la diferencia de otras causas respiratorias.

Diagnóstico

1. **Test del Sudor**: Mide la concentración de cloro. - **> 60 mEq/L**: Diagnóstico definitivo. - **30 - 60 mEq/L**: Valor indeterminado (requiere estudio genético). - **< 30 mEq/L**: Poco probable. 2. **Test Genético**: Para identificar la mutación específica (ej. ΔF508) y estudio familiar.

Manejo

- Soporte nutricional y kinesioterapia respiratoria. - **Antibióticos**: Cubrir gérmenes habituales, *S. aureus* y *Pseudomonas*. Se usan macrólidos (Azitromicina) como profilácticos por su efecto antiinflamatorio. - **Trasplante Pulmonar**: Opción final ante daño pulmonar avanzado.

3. Disquinesia Ciliar Primaria (Enfermedad de Cilio Inmóvil)

Es un trastorno genético donde los cilios del epitelio respiratorio no se mueven o lo hacen de forma inefectiva, impidiendo el aclaramiento mucociliar.

Clínica y Diferencias con FQ

TABLA 9.24.1: CARACTERÍSTICA VS FIBROSIS QUÍSTICA		
CARACTERÍSTICA	FIBROSIS QUÍSTICA	DISQUINESIA CILIAR
Bronquiectasias	Presentes	Presentes
Infección por Pseudomonas	Muy frecuente	Frecuente
Diarrea / Mala absorción	Presente	Ausente
ORL (Sinusitis/Otitis)	Variable	Muy frecuente (Rinosinusitis y OMA recurrente)
Situs Inversus	No asociado	Presente en ~50% de los casos

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El **Síndrome de Kartagener** es la tríada de: 1. Situs inversus (o dextrocardia), 2. Bronquiectasias y 3. Sinusitis crónica. Es una forma específica de disquinesia ciliar primaria.

Diagnóstico y Manejo

- **Diagnóstico Inicial**: Medición de **óxido nítrico nasal** (está muy bajo en estos pacientes). - **Confirmación**: **Biopsia** de epitelio ciliado (nasal o bronquial) para observar la ultraestructura ciliar mediante microscopía electrónica. - **Manejo**: Similar a la FQ (aseo bronquial, antibióticos agresivos y trasplante en etapas terminales).

4. Displasia Broncopulmonar (DBP)

Es la secuela de una lesión pulmonar aguda en el período neonatal, típicamente asociada a la prematuridad extrema.

Definición y Sospecha

Se define clínicamente en un recién nacido con antecedente de **Enfermedad de Membrana Hialina** que mantiene el **requerimiento de oxígeno suplementario más allá de las 36 semanas de edad gestacional corregida**.

Evaluación y Complicaciones

- **Radiografía**: Muestra un patrón de "esponja" con áreas de fibrosis y enfisema localizado. - **Ecocardiografía**: Es fundamental para buscar la complicación más grave: la **Hipertensión Pulmonar**.

Manejo

- **Evolución natural**: Los pulmones continúan desarrollándose durante la infancia, por lo que muchos pacientes mejoran con el tiempo. - **Soporte**: Oxigenoterapia domiciliar si es necesario y optimización nutricional. - **Farmacoterapia**: En casos de hipertensión pulmonar severa, se puede utilizar **Sildenafil** (inhibidor

de la fosfodiesterasa-5) para reducir la resistencia vascular pulmonar.

Resumen de Hallazgos Clave para el EUNACOM

- **SBO + Soplo + Cardiomegalia:** Pensar en **Cardiopatías Congénitas**.
- **SBO + Diarrea crónica + Pseudomonas:** Pensar en **Fibrosis Quística**.
- **SBO + Situs Inversus + Otitis/Sinusitis:** Pensar en **Disquinesia Ciliar Primaria**.
- **SBO + Antecedente de prematuridad + Oxígeno prolongado:** Pensar en **Displasia Broncopulmonar**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 22 años consulta por tos y sibilancias que aparecen 1 vez por semana, sin despertares nocturnos por asma en el último mes. Nunca ha sido hospitalizado. ¿Cuál es la clasificación de severidad y el tratamiento inicial más apropiado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo Crónico del Asma. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Objetivos: eliminar síntomas, prevenir hospitalizaciones, prevenir complicaciones y mantener función pulmonar.
- Paso 0 (todos): educación + vacunación (COVID-19, influenza, neumococo).
- Paso 1: salbutamol SOS (broncodilatador de acción corta).
- Paso 2: corticoides inhalados por horario (base de la prevención de recurrencias).
- Paso 3: agregar broncodilatadores de acción larga (formoterol, salmeterol) por horario.
- Última línea: corticoides orales (baratos, muchos efectos adversos) o fármacos biológicos (caros, menos efectos adversos).
- Clasificación de severidad: intermitente (<2/semana), persistente leve (3-6/semana), moderado (diario), severo (mayor parte del día).
- Despertares nocturnos: 0 (intermitente), 1-2/mes (leve), 3-4/mes (moderado), >1/semana (severo).
- Se clasifica por el peor criterio entre síntomas diurnos y nocturnos; en niños con resfriados, se agregan corticoides inhalados profilácticamente.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO CRÓNICO DEL ASMA)

PREGUNTA 1

Paciente de 22 años consulta por tos y sibilancias que aparecen 1 vez por semana, sin despertares nocturnos por asma en el último mes. Nunca ha sido hospitalizado. ¿Cuál es la clasificación de severidad y el tratamiento inicial más apropiado?

- A)** Asma persistente leve; salbutamol SOS + corticoides inhalados.
- B)** Asma intermitente; salbutamol SOS solamente.
- C)** Asma persistente moderada; salbutamol + corticoides inhalados + formoterol.
- D)** Asma intermitente; corticoides inhalados solamente.
- E)** Asma persistente leve; salbutamol SOS + montelukast.

PREGUNTA 2

Paciente asmático de 35 años en tratamiento con salbutamol SOS y corticoides inhalados presenta síntomas diarios que no ceden completamente, pero no durante todo el día. Tiene 3 despertares nocturnos este mes. ¿Cuál es el paso siguiente más apropiado?

- A)** Aumentar salbutamol a uso por horario cada 6 horas.
- B)** Agregar corticoides orales de mantención.
- C)** Agregar broncodilatador de acción larga (ej: formoterol) y considerar subir dosis de corticoide inhalado.
- D)** Suspender corticoides inhalados y cambiar a montelukast.
- E)** Iniciar fármacos biológicos (omalizumab).

PREGUNTA 3

Niño de 6 años con asma intermitente bien controlado, en tratamiento solo con salbutamol SOS, presenta un cuadro de resfriado común. ¿Cuál es la recomendación más apropiada?

- A)** No modificar el tratamiento ya que las infecciones virales no afectan el asma.
- B)** Agregar corticoides inhalados transitoriamente mientras dure el resfriado.
- C)** Iniciar corticoides orales profilácticamente.
- D)** Iniciar antibióticos para prevenir sobreinfección bacteriana.
- E)** Agregar broncodilatador de acción larga permanentemente.

RESUMEN: MANEJO CRÓNICO DEL ASMA

El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. El tratamiento sigue un esquema escalonado que se ajusta según la respuesta clínica y la severidad. El paso cero es la educación en todos los pacientes: comprensión de la enfermedad, identificación de desencadenantes y alérgenos evitables, y vacunación (COVID-19, influenza, neumococo). El paso 1 corresponde a broncodilatadores de acción corta (salbutamol) usados SOS. El paso 2 agrega corticoides inhalados por horario (cada 12 horas) como base de la prevención de recurrencias. El paso 3 incorpora broncodilatadores de acción larga (formoterol, salmeterol) por horario. El paso 4 añade inhibidores de leucotrienos (montelukast, zafirlukast, zileutón). El paso 5 agrega anticolinérgicos de larga acción (tiotropio). Finalmente, como última línea, están los corticoides orales (más baratos pero con muchos efectos adversos) y los fármacos biológicos (menos efectos adversos pero muy costosos). La clasificación por severidad permite guiar el inicio del tratamiento: intermitente (<2 veces/semana) se maneja solo con salbutamol SOS; persistente leve (3-6 veces/semana) agrega corticoides inhalados; persistente moderado (síntomas diarios pero no todo el día) agrega broncodilatadores de acción larga y sube dosis de corticoides; y severo (síntomas la mayor parte del día, la mayor parte de los días) usa altas dosis de todo lo anterior y eventualmente corticoides orales o biológicos. Los despertares nocturnos también clasifican severidad: ninguno (intermitente), 1-2/mes (leve), 3-4/mes (moderado), >1/semana (severo). Se clasifica por el peor criterio entre síntomas diurnos y nocturnos.